Módulo 1

Legislação farmacêutica

Hierarquia das normas e órgãos que regulam a farmácia comercial; Lei 5.991/1973 e Decreto 74.170/1974, Lei 6.360/1976 e Decreto 8.077/2013, Lei 6.437/1977, Lei 13.021/2014, genéricos e intercambialidade (Lei 9.787/1999, RDC 16/2007, RDC 58/2014), RDC 44/2009, AFE (RDC 275/2019), fracionamento, propaganda e venda remota, preços (Lei 10.742/2003, CMED) e CDC, LGPD e ética profissional (Res. CFF 724/2022 e 721/2022), conferidos em outubro de 2026.

- Hierarquia das normas e órgãos reguladores
- Comércio farmacêutico: Lei 5.991/1973 e Decreto 74.170/1974
- Registro, rotulagem e infrações sanitárias
- Lei 13.021/2014: a farmácia como unidade de saúde
- Genéricos, similares e intercambialidade
- Boas práticas, documentos e comercialização
- Preço de medicamentos e direitos do consumidor
- LGPD na farmácia
- Ética profissional e responsabilidade técnica

Hierarquia das normas e órgãos reguladores

A farmácia comercial obedece a um conjunto grande de normas, editadas por órgãos diferentes. Quem entende a hierarquia sabe qual regra prevalece quando duas parecem conflitar, a quem recorrer em caso de dúvida e quem pode fiscalizar e punir. A lógica é simples: a norma de nível inferior regulamenta a superior e não pode contrariá-la.

Hierarquia das normas

Nível	Quem edita	Exemplos na farmácia
Constituição Federal (1988)	Congresso, como poder constituinte	Saúde como direito de todos e dever do Estado (art. 196); SUS executa a vigilância sanitária (art. 200, II); defesa do consumidor (art. 5º, XXXII)
Lei federal	Congresso Nacional, com sanção do Presidente	Lei 5.991/1973, Lei 6.360/1976, Lei 6.437/1977, Lei 9.787/1999, Lei 13.021/2014, CDC, LGPD
Decreto	Presidente da República, para regulamentar lei	Decreto 74.170/1974 (regulamenta a Lei 5.991), Decreto 8.077/2013 (regulamenta a Lei 6.360), Decreto 85.878/1981 (atribuições do farmacêutico)
Resolução e instrução normativa da Anvisa	Diretoria Colegiada da Anvisa	RDC 44/2009 (boas práticas), RDC 275/2019 (AFE), RDC 96/2008 (propaganda), IN 285/2024 (lista de MIP)
Portaria	Ministério da Saúde e suas secretarias	Portaria SVS/MS 344/1998 (controlados), atualizada por RDC
Resolução de conselho profissional	Conselho Federal de Farmácia (CFF)	Res. CFF 724/2022 (Código de Ética), Res. CFF 721/2022 (responsabilidade técnica)
Norma estadual e municipal	Assembleias, câmaras, secretarias de saúde	Código sanitário, validade da licença, plantão por rodízio, regras locais de licenciamento

Duas consequências práticas. Primeiro, uma RDC não pode criar obrigação que contrarie lei; quando a lei muda, a RDC precisa ser lida à luz da nova redação. Segundo, as resoluções do CFF regulam o **exercício profissional** do farmacêutico, e não o funcionamento sanitário do estabelecimento. Uma resolução do CFF pode punir eticamente o profissional, mas quem interdita a loja é a vigilância sanitária.

Estados e municípios também legislam. A Constituição dá competência concorrente à União, aos estados e ao Distrito Federal sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII) e permite ao município legislar sobre assunto local e suplementar a legislação federal e estadual (art. 30, I e II). A Lei 5.991/1973 confirma esse desenho: o licenciamento é feito pelo órgão sanitário estadual conforme a legislação supletiva local (art. 21) e o plantão por rodízio segue normas estaduais e municipais (art. 56).

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) é o conjunto de órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que regulam, normatizam, controlam e fiscalizam produtos e serviços de interesse da saúde (Lei 9.782/1999, art. 1º). A mesma lei criou a Anvisa, autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde (art. 3º), a quem compete, entre outras coisas, autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação e de comercialização de medicamentos (art. 7º, VII). Daí vem a AFE da farmácia.

Órgão	Papel	O que significa para a farmácia
Anvisa	Coordena o SNVS, edita RDC e IN, registra medicamentos, concede AFE e AE	Define as regras nacionais de boas práticas, controlados, antimicrobianos e propaganda
VISA estadual e municipal	Licencia e inspeciona os estabelecimentos	Emite a licença (alvará) sanitária, inspeciona a loja, lavra auto de infração
CFF	Órgão supremo dos conselhos, edita resoluções e o Código de Ética (Lei 3.820/1960, arts. 2º e 6º)	Define atribuições e deveres éticos do farmacêutico
CRF	Registra profissionais, fiscaliza o exercício da profissão e pune infrações (Lei 3.820/1960, art. 10)	Emite a certidão de regularidade e verifica a presença do farmacêutico
CMED	Regula o mercado de medicamentos e fixa critérios de preço (Lei 10.742/2003, arts. 5º e 6º)	Publica o PMC; exige lista de preços à disposição do consumidor
Procon e ANPD	Defesa do consumidor; proteção de dados pessoais	Preço, informação, cadastro com CPF, uso de dados de saúde

O QUE DIZ A NORMA

"O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compreende o conjunto de ações definido pelo § 1º do art. 6º e pelos arts. 15 a 18 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, executado por instituições da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" (Lei 9.782/1999, art. 1º).

Duas fiscalizações diferentes

A vigilância sanitária fiscaliza o **estabelecimento e os produtos**: estrutura, armazenamento, documentos, dispensação, receitas, escrituração. O CRF fiscaliza o **exercício profissional**: se há farmacêutico habilitado, se ele está presente no horário declarado, se cumpre o Código de Ética. Quando a VISA encontra infração ética, comunica o CRF (Lei 5.991/1973, art. 52). O CRF, por sua vez, envia às autoridades competentes os fatos que não sejam de sua alçada (Lei 3.820/1960, art. 10, c).

Somente quem está inscrito no CRF pode exercer atividade farmacêutica (Lei 3.820/1960, art. 13), e a empresa que explora serviço que exige farmacêutico precisa provar ao conselho que a atividade é

exercida por profissional habilitado e registrado (art. 24). Os temas de controlados e antimicrobianos têm módulos próprios (ver os módulos da Portaria 344/98 e da RDC 471/2021).

NO BALCÃO

Diante de uma regra que você não conhece, faça três perguntas: qual é a norma, quem a editou e se ela segue vigente. O texto consolidado das normas da Anvisa fica no AnvisaLegis; leis e decretos, no portal do Planalto; resoluções do CFF, no Diário Oficial da União e no site do conselho. Apostila e grupo de mensagens não são fonte.

CASO

Fiscal do CRF chega às 20h e encontra a drogaria aberta só com balconistas. A farmacêutica declarou ao CRF o horário das 8h às 18h. A loja responde perante a VISA por funcionar sem farmacêutico (Lei 13.021/2014, art. 6º, I), e a profissional não cometeu falta ética, porque o horário descoberto não era o dela. O problema está na escala: faltava um segundo farmacêutico anotado no CRF para cobrir o horário estendido (Res. CFF 721/2022, art. 3º).

Comércio farmacêutico: Lei 5.991/1973 e Decreto 74.170/1974

A Lei 5.991/1973 é a lei-base do comércio de medicamentos. Ela define os tipos de estabelecimento, diz quem pode dispensar, trata da responsabilidade técnica, do licenciamento e do receituário. Seu regulamento é o Decreto 74.170/1974, que segue em vigor com alterações. Parte dos dispositivos foi revogada ou ganhou nova redação ao longo de 50 anos, por isso a leitura deve ser feita no texto compilado do Planalto.

Definições que caem em prova

Estabelecimento	Definição legal (art. 4º)	Pode manipular?	Dispensa medicamento?
Farmácia	Manipulação de fórmulas magistrais e oficinais e comércio de drogas, medicamentos, insumos e correlatos, incluindo dispensação (inciso X)	Sim	Sim
Drogaria	Dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos e correlatos em suas embalagens originais (inciso XI)	Não	Sim, em embalagem original
Ervanaria	Dispensação de plantas medicinais (inciso XII)	Não	Só plantas medicinais
Posto de medicamentos e unidade volante	Venda exclusiva de industrializados em embalagem original, de relação oficial, em localidade sem farmácia ou drogaria (inciso XIII)	Não	Só os da relação

Estabelecimento	Definição legal (art. 4º)	Pode manipular?	Dispensa medicamento?
Dispensário de medicamentos	Setor de fornecimento de industrializados, privativo de pequena unidade hospitalar (inciso XIV)	Não	Só aos pacientes da unidade

A Lei 13.021/2014 manteve a mesma divisão com outros nomes: farmácia sem manipulação ou drogaria e farmácia com manipulação (art. 3º, parágrafo único). **Dispensação** é o ato de fornecer ao consumidor drogas, medicamentos, insumos e correlatos, remunerado ou não (Lei 5.991/1973, art. 4º, XV).

O QUE DIZ A NORMA

"A dispensação de medicamentos é privativa de: a) farmácia; b) drogaria; c) posto de medicamento e unidade volante; d) dispensário de medicamentos." (Lei 5.991/1973, art. 6º). O comércio de drogas, medicamentos e insumos é privativo das empresas e estabelecimentos definidos na lei (art. 5º).

O que a drogaria pode vender e fazer

- Medicamentos industrializados em embalagem original, isentos ou sob prescrição, inclusive controlados, conforme as atividades da AFE e da licença.
- Correlatos permitidos por lei: aparelhos e acessórios, produtos para diagnóstico, higiene pessoal e de ambiente, cosméticos, perfumes, dietéticos, produtos óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários (Lei 5.991/1973, art. 5º, §1º; Decreto 74.170/1974, art. 4º).
- Medicamentos fracionados a partir de embalagem fracionável (Decreto 74.170/1974, art. 9º, parágrafo único, redação do Decreto 5.775/2006; RDC 80/2006, art. 1º).
- Serviços farmacêuticos previstos na RDC 44/2009 e indicados na licença sanitária (art. 61, §§3º e 4º).

A drogaria **não** manipula, não pode captar receitas de fórmulas magistrais e oficinais para outra empresa, nem mesmo para filial da mesma rede (Lei 5.991/1973, art. 36, §1º; RDC 44/2009, art. 50), e não dispensa plantas medicinais, privativas de farmácias e ervanarias (Lei 5.991/1973, art. 7º). Para comércio de alimentos e serviços, a RDC 275/2019 remete à RDC 44/2009 e à IN 9/2009 (art. 7º). Artigos de conveniência dependem também de lei estadual; a resposta muda conforme o estado.

Supermercados: Lei 15.357/2026

A Lei 15.357, de 20 de março de 2026, acrescentou os §§2º a 7º ao art. 6º da Lei 5.991/1973. Ela permite instalar farmácia ou drogaria **na área de venda de supermercados**, em ambiente delimitado, segregado e exclusivo, operada diretamente pelo supermercado ou por contrato com farmácia licenciada. As exigências são as mesmas de qualquer farmácia:

- presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento (§3º);
- controlado só é entregue após o pagamento, ou vai do balcão ao caixa em embalagem lacrada, inviolável e identificável (§4º);

- é vedado oferecer medicamento em bancadas, estandes ou gôndolas fora do espaço da farmácia (§5º);
- aplicam-se integralmente a Lei 5.991/1973, a Lei 13.021/2014 e a Lei 6.360/1976 (§7º).

A mesma lei permitiu que farmácias e drogarias licenciadas contratem canais digitais e plataformas de comércio eletrônico para logística e entrega, desde que cumpram a regulamentação sanitária (§6º). Supermercado sem farmácia instalada continua sem poder vender medicamento: a dispensação segue privativa dos estabelecimentos do art. 6º.

Licença, endereço e funcionamento

Regra	Artigo da Lei 5.991/1973
Comércio e dispensação só por estabelecimento licenciado pelo órgão sanitário estadual, conforme legislação supletiva	Art. 21
Pedido de licença instruído com constituição da empresa, contrato com o responsável técnico e prova de habilitação expedida pelo CRF	Art. 22
Validade da licença fixada pela autoridade sanitária local conforme o risco das atividades	Art. 25 (redação da Lei 13.097/2015)
Mudança de endereço exige licença prévia	Art. 28
Estabelecimento fechado por mais de 120 dias tem a licença cancelada	Art. 33
Filial é considerada autônoma para licenciamento e responsabilidade	Art. 34
Proibido usar dependência da farmácia como consultório ou para fim diverso do licenciado	Art. 55
Plantão obrigatório por rodízio, conforme norma estadual e municipal	Art. 56

Receituário na lei

A receita só será aviada se estiver escrita no vernáculo, sem abreviações, legível, com nomenclatura e pesos e medidas oficiais; com nome e endereço do paciente e modo de usar; e com data, assinatura, endereço e inscrição do profissional no conselho (art. 35, I a III, redação da Lei 14.063/2020). O receituário vale em todo o território nacional, inclusive o de controlados, nos termos da regulação (§1º). Receita eletrônica exige assinatura eletrônica avançada ou qualificada, e a de controlados exige a qualificada (§§2º e 3º). Quando a dose ultrapassar os limites farmacológicos ou houver incompatibilidade, o responsável técnico solicita confirmação expressa ao prescritor (art. 41).

NO BALCÃO

Cliente apresenta receita de clínica de outro estado. A origem não invalida a receita (art. 35, §1º). Confira os requisitos do art. 35 e, se for controlado, as regras próprias da Portaria 344/98 e da RDC 1.000/2025 (ver o módulo da Portaria 344/98).

CASO

Uma drogaria de bairro recebe de uma cliente a receita de uma pomada manipulada e oferece "mandar fazer" na farmácia de manipulação parceira, devolvendo o produto pronto no dia seguinte. A prática é captação de receita magistral, vedada mesmo entre filiais da mesma empresa (Lei 5.991/1973, art. 36, §1º; RDC 44/2009, art. 50). O correto é orientar a cliente a levar a receita diretamente a uma farmácia com manipulação.

Registro, rotulagem e infrações sanitárias

Antes de chegar à prateleira, o medicamento passa por duas exigências: a empresa precisa estar autorizada e o produto precisa estar registrado. Essas regras estão na Lei 6.360/1976, a lei da vigilância sanitária de produtos. As punições por descumprir qualquer norma sanitária estão na Lei 6.437/1977.

Lei 6.360/1976 e seu regulamento

A lei submete à vigilância sanitária medicamentos, drogas, insumos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, perfumes e saneantes (art. 1º). Só empresas autorizadas e com estabelecimento licenciado podem fabricar, fracionar, embalar, armazenar ou expedir esses produtos (art. 2º). O regulamento vigente é o **Decreto 8.077/2013**, que revogou o antigo Decreto 79.094/1977 (art. 25). Ele exige autorização da Anvisa e licenciamento local para o funcionamento das empresas (art. 2º) e remete à Lei 6.437/1977 a responsabilização por infração (art. 24).

O QUE DIZ A NORMA

"Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde." (Lei 6.360/1976, art. 12). Hoje o registro é concedido pela Anvisa, com prazo de renovação definido por ela, não superior a 10 anos (art. 12, §1º).

Dispositivo	O que regula	Ponto que cai no balcão
Art. 3º, XX a XXV	Definições de similar, genérico, referência, intercambiável, bioequivalência e biodisponibilidade	Base legal da troca de medicamento (tópico de genéricos)
Art. 12	Registro prévio obrigatório	Produto sem registro não pode ser exposto nem vendido
Art. 57, §1º	DCB ou DCI com letras de tamanho nunca inferior à metade do nome comercial, inclusive em material promocional	Ajuda o cliente a identificar o princípio ativo
Art. 57, §2º	Rótulos que se diferenciem e inibam erro de dispensação	Embalagens parecidas exigem conferência dupla
Art. 57, §3º	Alerta para substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem (Lei 14.806/2024)	Orientar atletas que perguntam sobre doping

Dispositivo	O que regula	Ponto que cai no balcão
Art. 58, §1º	Propaganda de medicamento sob prescrição restrita a publicações para médicos, dentistas e farmacêuticos	Cartaz de tarjado na vitrine é irregular
Art. 59	Proíbe rotulagem ou propaganda que induza a erro sobre natureza, composição ou finalidade	Atenção a produtos com promessas terapêuticas
Art. 79	Informes de acidentes ou reações nocivas devem ser transmitidos à autoridade sanitária	Notificar no VigiMed

Consultar o registro é rotina simples: o número aparece na embalagem e pode ser conferido na consulta de medicamentos do portal da Anvisa, que informa titular, apresentações, categoria de venda e situação do registro. Isso resolve dúvidas sobre produto importado, cancelado ou vendido por fornecedor desconhecido.

Lei 6.437/1977: infrações e penalidades

Essa lei tipifica as infrações à legislação sanitária federal e fixa as penas. As regras de classificação, valores de multa e prazos do processo administrativo estão detalhadas no módulo da Portaria 344/98. Aqui interessam as infrações mais comuns no comércio farmacêutico.

Art. 10	Conduta	Exemplo na farmácia
I e IV	Fazer funcionar estabelecimento ou comercializar produto sem licença, registro ou autorização, ou contrariando a legislação	Loja aberta com licença vencida; venda de produto sem registro
X	Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora	Recusar acesso ao estoque ou aos registros
XI	Aviar receita em desacordo com a prescrição ou com a norma	Trocar medicamento fora das regras de intercambialidade
XII	Vender medicamento que depende de prescrição sem observar essa exigência	Venda de tarjado sem receita
XVIII	Expor à venda ou entregar produto vencido, ou apor nova data	Vencido misturado ao estoque de venda
XXV e XXVI	Exercer profissão de saúde sem habilitação ou confiar o encargo a pessoa não habilitada	Balconista que indica e dispensa como se fosse farmacêutico
XXIX	Transgredir outras normas legais e regulamentares de proteção da saúde	Descumprir a RDC 44/2009 (art. 99 da própria RDC remete à Lei 6.437/1977)

As penas vão de advertência e multa a apreensão e inutilização de produto, interdição, cancelamento de autorização e de licença, aplicadas de forma isolada ou cumulativa (art. 2º). A responsabilidade sanitária não exclui a civil, a penal e a ética. O mesmo fato pode gerar auto de infração da VISA, processo ético no CRF e ação do consumidor.

ATENÇÃO

Produto vencido na área de venda é infração própria (Lei 6.437/1977, art. 10, XVIII) e produto impróprio ao consumo pelo CDC (Lei 8.078/1990, art. 18, §6°, I). Além disso, a RDC 44/2009 proíbe dispensar medicamento cuja posologia não possa ser concluída dentro do prazo de validade (art. 51, §2°).

NO BALCÃO

Representante oferece lote de dermocosmético "importado direto" a preço muito baixo, sem nota fiscal. Recuse: o Código de Ética manda recusar produto sem registro ou notificação na Anvisa, sem rastreabilidade ou sem documento fiscal (Res. CFF 724/2022, art. 15, II), e a compra configura infração sanitária (Lei 6.437/1977, art. 10, IV).

Lei 13.021/2014: a farmácia como unidade de saúde

A Lei 13.021/2014 trata do exercício e da fiscalização das atividades farmacêuticas. Ela mudou o modo como a lei enxerga a farmácia: deixou de ser apenas um ponto de comércio e passou a ser uma unidade de prestação de serviços de saúde. Tramitou no Congresso de 1993 a 2014 (PL 41/1993 no Senado) e foi sancionada com vetos.

O QUE DIZ A NORMA

"Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos." (Lei 13.021/2014, art. 3°)

Dispositivos principais

Artigo	Conteúdo	Consequência prática
Art. 2°	Define assistência farmacêutica: ações e serviços para assistência terapêutica integral, com o medicamento como insumo essencial e visando ao uso racional	Base para os serviços clínicos na farmácia comercial
Art. 3°, parágrafo único	Classifica as farmácias em sem manipulação (drogaria) e com manipulação	Drogaria passa a ser uma espécie de farmácia
Art. 5°	Farmácia de qualquer natureza exige responsabilidade e assistência técnica de farmacêutico habilitado	Não há farmácia sem farmacêutico
Art. 6°	Exige autorização e licenciamento, presença do farmacêutico durante todo o horário (I), localização sanitária conveniente (II), equipamentos para imunobiológicos (III) e equipamentos exigidos pela vigilância (IV)	Escala de farmacêuticos cobre 100% do horário

Artigo	Conteúdo	Consequência prática
Art. 7º	Farmácias podem dispor de medicamentos, vacinas e soros conforme o perfil epidemiológico da região	Fundamento para vacinação em farmácia, com a regulação sanitária própria
Art. 10	Farmacêutico e proprietário agem solidariamente pelo uso racional	Responsabilidade compartilhada
Art. 11	O proprietário não pode desautorizar ou desconsiderar orientações técnicas do farmacêutico; deve dar condições de trabalho	Meta de venda não se sobrepõe à decisão técnica
Art. 12	Na baixa do farmacêutico, contratar outro em até 30 dias	Prazo para substituir o profissional que saiu
Art. 13	Deveres do farmacêutico: notificar reações adversas e intoxicações, manter cadastro técnico, acompanhamento e perfil farmacoterapêutico, orientar o paciente	Farmacovigilância e orientação são obrigações legais
Art. 14	Na dispensação, observar os aspectos técnicos e legais do receituário	Conferência da receita é dever do farmacêutico
Art. 16	Fiscal farmacêutico não pode ser RT, proprietário ou sócio de estabelecimento farmacêutico	Imparcialidade da fiscalização

Vetos e o que ficou de fora

A Mensagem de veto nº 232/2014 vetou quatro artigos. Conhecer o veto ajuda a entender por que algumas regras que circulam como "previstas na lei" não existem.

Dispositivo vetado	O que dizia	Razão do veto
Art. 9º	Somente farmácias poderiam dispensar medicamentos, cosméticos com indicação terapêutica, fórmulas e fitoterápicos	Restringiria postos e dispensários em regiões isoladas; o conceito de cosmético com indicação terapêutica não existe na legislação
Art. 15	Fiscalização dos estabelecimentos exercida pelo fiscal farmacêutico	Interferiria na competência sanitária de estados e municípios
Art. 17	Postos, dispensários e unidades volantes teriam 3 anos para virar farmácia	Mesma razão do art. 9º
Art. 18	Vigência na data da publicação	Dar 45 dias de adaptação

Por causa do veto ao art. 9º, postos de medicamentos e dispensários continuam regidos pela Lei 5.991/1973. Por causa do veto ao art. 15, a fiscalização sanitária segue com a VISA; o CRF fiscaliza o exercício profissional.

Logo após a sanção, a Medida Provisória 653/2014 incluiu um parágrafo no art. 6º que estendia às farmácias enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte o art. 15 da Lei 5.991/1973 (técnico responsável). A MP não foi convertida em lei e sua vigência se encerrou; o texto compilado registra o dispositivo como sem vigência.

Relação com a Lei 5.991/1973

A Lei 13.021/2014 não revogou a Lei 5.991/1973; as duas convivem. Onde há sobreposição, a lei mais nova e mais específica orienta a leitura. A Lei 5.991/1973 ainda admite o funcionamento por até 30 dias sem responsável técnico ou substituto, período em que não podem ser vendidos medicamentos sujeitos a controle especial nem aviadas fórmulas (art. 17). A Lei 13.021/2014 exige farmacêutico presente durante todo o horário (art. 6º, I) e dá 30 dias para contratar novo profissional após a baixa (art. 12). Na prática da VISA e do CRF, a loja sem farmacêutico no horário está irregular.

PONTO-CHAVE

A lei chama a farmácia de unidade de assistência à saúde e impõe ao farmacêutico deveres clínicos (art. 13). Na fiscalização e na prova, a pergunta central costuma ser se havia farmacêutico presente, se ele orientou e se notificou o que devia notificar.

NO BALCÃO

O gerente pede para "segurar" a recusa de uma venda de antigripal a um hipertenso descompensado, porque a loja está abaixo da meta. A decisão técnica é sua: o proprietário não pode desautorizar a orientação do farmacêutico (Lei 13.021/2014, art. 11). Explique ao cliente o motivo, ofereça alternativa segura e registre o atendimento.

CASO

A única farmacêutica de uma drogaria pede demissão e sai no mesmo dia. O dono quer manter a loja aberta "vendendo só o que não precisa de receita" até contratar outra. A Lei 5.991/1973 proíbe vender controlados nesse intervalo (art. 17), mas a Lei 13.021/2014 exige farmacêutico durante todo o horário (art. 6º, I), inclusive para dispensar MIP. A conduta correta é contratar farmacêutico substituto ou reduzir o horário, comunicar o CRF e a VISA e contratar o novo RT em até 30 dias (art. 12).

Genéricos, similares e intercambialidade

A troca de um medicamento por outro na farmácia é ato regulado. Ela só é permitida entre produtos cuja equivalência terapêutica foi comprovada à Anvisa, e só o farmacêutico pode fazê-la. A Lei 9.787/1999 criou o medicamento genérico, alterando a Lei 6.360/1976, e mandou a Anvisa regulamentar inclusive os critérios de dispensação, "respeitada a decisão expressa de não intercambialidade do profissional prescritor" (art. 2º, IV).

Definições legais

Tipo	Definição (Lei 6.360/1976, art. 3º)	Como reconhecer na embalagem
Referência	Produto inovador registrado e comercializado no país, com eficácia, segurança e qualidade comprovadas no registro (XXII)	Nome comercial; consta da lista de referência da Anvisa
Genérico	Similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende intercambiável, geralmente produzido após a expiração da patente, designado pela DCB ou DCI (XXI)	Sem nome comercial; identificado pela DCB, com a faixa amarela e a letra G
Similar	Mesmos princípios ativos, concentração, forma, via, posologia e indicação do registrado, podendo diferir em tamanho, forma, validade, embalagem, rotulagem e excipientes; sempre com nome comercial ou marca (XX, redação da Lei 13.235/2015)	Nome comercial
Similar intercambiável	Similar cujos estudos de equivalência farmacêutica, bioequivalência ou bioisenção foram aprovados pela Anvisa (RDC 58/2014, art. 2º)	Bula com a frase "MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA" (RDC 58/2014, art. 6º)

Produto farmacêutico intercambiável é o equivalente terapêutico de um referência, comprovados essencialmente os mesmos efeitos de eficácia e segurança (art. 3º, XXIII). **Bioequivalência** é a demonstração de equivalência farmacêutica com biodisponibilidade comparável no mesmo desenho experimental (XXIV); **biodisponibilidade** indica velocidade e extensão da absorção (XXV).

Quais trocas são permitidas

Medicamento prescrito	Pode ser trocado por	Não pode ser trocado por
Referência, pelo nome comercial	Genérico correspondente; similar intercambiável com aquele referência	Similar não intercambiável; outro princípio ativo, dose ou forma
Genérico	Referência correspondente	Similar, mesmo intercambiável
Similar intercambiável, pelo nome comercial	Referência correspondente	Genérico; outro similar
Similar não intercambiável	Nenhum	Qualquer outro

Receita escrita pela DCB permite dispensar o genérico ou o medicamento de referência correspondente (RDC 16/2007, Anexo I, VI, 2.3 e 2.3.1).

A intercambialidade é sempre estabelecida em relação ao **referência**. Genérico e similar intercambiável foram comparados ao referência, e não entre si. Por isso a Anvisa informa que a troca entre genérico e similar não é possível. A relação de similares intercambiáveis fica na consulta de medicamentos do portal da Anvisa, atualizada diariamente. A RDC 58/2014 não se aplica aos MIP (art. 1º, §2º).

O QUE DIZ A NORMA

"Será permitida ao profissional farmacêutico a substituição do medicamento prescrito pelo medicamento genérico correspondente, salvo restrições expressas pelo profissional prescritor" e, nesses casos, "o profissional farmacêutico deverá indicar a substituição realizada na prescrição, apor seu carimbo a seu nome e número de inscrição do Conselho Regional de Farmácia, datar e assinar" (RDC 16/2007, Anexo I, item VI, 2.1 e 2.2).

Quem pode trocar e como registrar

- **Quem**: o farmacêutico. O balconista não decide troca; a substituição é avaliação técnica do receituário (Lei 13.021/2014, art. 14; Decreto 85.878/1981, art. 1º, I).
- **Com quem**: com o usuário. O Código de Ética garante o direito de "realizar a intercambialidade de medicamentos, respeitando a decisão do usuário, dentro dos limites legais, e documentando o ato" (Res. CFF 724/2022, art. 12, IX).
- **Quando não**: se o prescritor vetou a troca. A manifestação de não intercambialidade é feita por item prescrito, de forma clara, legível e inequívoca, de próprio punho, sem outras formas de impressão (RDC 16/2007, Anexo I, VI, 1.3).
- **Registro**: anotar a troca na receita, com carimbo, nome, CRF, data e assinatura (VI, 2.2), e orientar o paciente sobre a dispensação feita (VI, 2.4).

No SUS, prescrições e compras de medicamentos usam obrigatoriamente a DCB (Lei 9.787/1999, art. 3º). Nos serviços privados, o prescritor escolhe entre DCB e nome comercial (RDC 16/2007, Anexo I, VI, 1.2). A farmácia deve manter à disposição dos usuários, em local visível, a lista atualizada de genéricos divulgada pela Anvisa (RDC 44/2009, art. 42, §1º).

ATENÇÃO

Trocar fora dessas regras é aviar receita em desacordo com a prescrição, infração sanitária (Lei 6.437/1977, art. 10, XI). Exemplos de troca proibida: amoxicilina por cefalexina, comprimido por suspensão, similar não intercambiável por referência. Medicamento biológico não tem genérico, e a propaganda de biológico não pode comparar preços (RDC 96/2008, art. 11, §3º).

NO BALCÃO

Antes de oferecer a troca: confira se a receita tem veto de próprio punho, consulte a lista da Anvisa quando houver similar, mostre ao cliente as opções e o preço, deixe que ele escolha e registre a troca no verso da receita. A troca também se aplica a antimicrobianos, com o mesmo registro (ver o módulo da RDC 471/2021).

CASO

Receita particular de losartana potássica 50 mg pelo nome de marca do referência, sem restrição de troca. O cliente pergunta se pode levar um similar mais barato. O farmacêutico consulta o portal da Anvisa: o similar consta como intercambiável com aquele referência. Explica a diferença, o cliente escolhe o similar, e o farmacêutico anota a substituição na receita com carimbo, CRF, data e assinatura. Se a receita trouxesse o nome comercial de um similar e o cliente pedisse o genérico, a troca não seria possível.

Boas práticas, documentos e comercialização

As boas práticas farmacêuticas em farmácias e drogarias estão na **RDC 44/2009**. Em outubro de 2026 ela consta no AnvisaLegis como vigente com alterações, entre elas as da RDC 41/2012 (MIP em autosserviço), da RDC 786/2023 (serviços e exames) e da RDC 812/2023 (venda remota de controlados). Não há norma substituta publicada até esta data. Infraestrutura, POPs e inspeção são tratados no módulo de procedimentos operacionais padrão; aqui ficam os documentos e as regras de comercialização.

Documentos do estabelecimento

Documento	Quem emite	Base legal	Observação
Autorização de Funcionamento (AFE)	Anvisa	RDC 44/2009, art. 2º, I; RDC 275/2019	Por estabelecimento; vale a partir da publicação no DOU
Autorização Especial (AE)	Anvisa	RDC 44/2009, art. 2º, II; RDC 275/2019, art. 2º, II	Só para farmácia que manipula substâncias da Portaria 344/98
Licença ou alvará sanitário	VISA estadual ou municipal	RDC 44/2009, art. 2º, III; Lei 5.991/1973, art. 21	Afixada em local visível; lista as atividades autorizadas
Certidão de Regularidade Técnica	CRF	RDC 44/2009, art. 2º, IV; Res. CFF 721/2022, art. 8º	Afixada; nome e horário de todos os farmacêuticos e do substituto
Manual de Boas Práticas Farmacêuticas	O próprio estabelecimento	RDC 44/2009, arts. 2º, V, e 85	Específico da loja, com POPs (art. 86)

Quando AFE, licença e certidão não trazem todos os dados, a loja afixa cartaz com razão social, CNPJ, número da AFE e da AE, nome e CRF do RT e dos substitutos, horário de cada farmacêutico e telefones do CRF e da VISA (RDC 44/2009, art. 2º, §2º).

AFE e AE: RDC 275/2019

A RDC 275/2019 rege a concessão, alteração e cancelamento da AFE e da AE de farmácias e drogarias. A AFE é ato privativo da Anvisa que autoriza o funcionamento (art. 2º, I); a AE autoriza a farmácia de manipulação a trabalhar com substâncias da Portaria 344/98 (art. 2º, II). Drogaria que só dispensa controlado industrializado opera com AFE. Pontos de prova:

- A AFE não permite atividade que não esteja na licença local; as atividades só podem ser executadas se também constarem da licença (art. 4º, §§4º e 5º).
- A Anvisa tem 30 dias para analisar o pedido de concessão; sem manifestação, a concessão é automática, sem impedir análise e cancelamento posteriores (art. 5º).
- O atesto de conformidade sanitária é do órgão sanitário local (art. 6º).
- Mudança de razão social, endereço, RT, representante legal e redução de atividades são alterações de implementação imediata após o protocolo, desde que contempladas na licença (art. 13, §1º).
- Quem vende pela internet informa o endereço do site na AFE (RDC 44/2009, art. 55).

Exposição e dispensação

Medicamentos ficam em área de circulação restrita aos funcionários; os isentos de prescrição podem ficar ao alcance do usuário em autosserviço (RDC 44/2009, art. 40, §§1º e 2º, redação da RDC 41/2012), agrupados por princípio ativo e identificados pela DCB, separados dos demais produtos, com o cartaz "MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO" (art. 41). Os detalhes do autosserviço estão no módulo de MIP.

Na dispensação, medicamento sob prescrição só sai com a receita (art. 43); o farmacêutico avalia legibilidade, paciente, medicamento, posologia, duração, data e prescritor (art. 44) e não dispensa receita ilegível ou que induza a erro (art. 45). A intercambialidade, o fracionamento e os controlados seguem normas específicas (arts. 47 a 49).

Fracionamento: RDC 80/2006

Farmácias e drogarias podem fracionar medicamentos a partir de embalagens especialmente desenvolvidas para isso, garantidas as características do produto registrado (RDC 80/2006, art. 1º). O fracionamento **não** se aplica a controlados (art. 1º, parágrafo único) e é responsabilidade do farmacêutico (art. 5º). A apresentação da prescrição é condição essencial, exceto para MIP, que podem ser fracionados sob orientação do farmacêutico (art. 8º e §§1º e 2º). Os procedimentos de rotulagem e prevenção de trocas estão no módulo de POPs.

Propaganda e publicidade: RDC 96/2008

- Propaganda de medicamento sob prescrição só em meios destinados a profissionais habilitados a prescrever ou dispensar (art. 27; Lei 6.360/1976, art. 58, §1º).
- Programas de fidelidade da farmácia não podem usar medicamento como objeto de pontuação, troca, sorteio ou prêmio, e o regulamento deve informar essa restrição (art. 10).
- Comparação de preços dirigida ao consumidor só entre intercambiáveis (art. 11); ao anunciar desconto, informar também o preço integral (art. 11, §4º).
- Empresas não podem dar brindes ou vantagens a prescritores, dispensadores e balconistas (art. 5º).

Venda remota e entrega em domicílio

Só farmácia ou drogaria **aberta ao público**, com farmacêutico presente durante todo o horário, pode dispensar medicamento pedido por telefone ou internet; o estoque tem de estar em farmácia aberta ao público (RDC 44/2009, art. 52, caput e §3º). Medicamento sob prescrição exige apresentação e avaliação

da receita pelo farmacêutico (§1º). Controlado pedido a distância é vedado, salvo as permissões da legislação específica (§2º, redação da RDC 812/2023). Essa legislação é a própria RDC 812/2023, que incluiu na Portaria 344/98 os arts. 34-A e 34-B sobre a entrega remota de controlados, com regras próprias (ver o módulo da Portaria 344/98).

Exigência	Artigo da RDC 44/2009
Pedido pelo site da própria farmácia ou rede, domínio ".com.br"	Art. 53, caput e §1º
Página principal com razão social, CNPJ, endereço, horário, telefone, RT e CRF, licença, AFE e AE	Art. 53, §1º, I a V
Proibida oferta de medicamento em site que não pertença a farmácia ou drogaria licenciada	Art. 53, §2º
Sem imagem, propaganda ou promoção de tarjado no site; lista de preços só com nome, DCB, apresentação, registro, detentor e preço	Art. 54
Transporte sob responsabilidade da farmácia, com controle de temperatura e POP	Art. 56
Canal direto com o farmacêutico e cartão com nome, telefone e endereço junto ao produto	Art. 58
Sigilo dos dados; vedado usá-los para promover consumo de medicamentos	Art. 59

A Lei 15.357/2026 autorizou a farmácia licenciada a contratar plataformas digitais para **logística e entrega**, mantida a regulamentação sanitária (Lei 5.991/1973, art. 6º, §6º). A interpretação de como isso convive com o art. 53 da RDC 44/2009 ainda depende de posicionamento da Anvisa; até lá, a dispensação, a avaliação da receita e a responsabilidade continuam da farmácia licenciada.

NO BALCÃO

Pedido por aplicativo de amoxicilina com foto da receita. Antes de separar o produto, o farmacêutico avalia a receita e confirma como a via original será retida no ato da entrega, conforme a regra do antimicrobiano (ver o módulo da RDC 471/2021). Junto com o pacote vai o cartão com nome do farmacêutico e telefone da loja (RDC 44/2009, art. 58, §2º).

CASO

Na renovação da licença, a VISA constata que a drogaria aplica injetáveis, mas a licença lista só dispensação. O serviço é irregular, porque só são regulares os serviços indicados no licenciamento (RDC 44/2009, art. 61, §3º), e a AFE não supre a falta da atividade na licença (RDC 275/2019, art. 4º, §4º). A farmácia suspende o serviço, pede a inclusão na licença e atualiza a AFE.

Preço de medicamentos e direitos do consumidor

O preço do medicamento no Brasil é regulado. A **Lei 10.742/2003** criou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), que define critérios de preço e de margem de comercialização para fabricantes, distribuidores, farmácias e drogarias (arts. 5º e 6º, II e V). O ajuste anual segue um modelo de

teto baseado no IPCA, num fator de produtividade e num fator de ajuste de preços relativos (art. 4º, §§1º a 4º).

Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor

Sigla	O que é	Quem deve respeitar
PF	Preço Fábrica: teto de venda do laboratório e do distribuidor	Indústria e distribuidoras
PMC	Preço Máximo ao Consumidor: teto de venda na farmácia, que varia conforme a alíquota de ICMS do estado	Farmácias e drogarias

Para 2026, a Resolução CM-CMED nº 4, de 30 de março de 2026, autorizou ajuste máximo a partir de 31 de março de 3,81% no nível 1, 2,47% no nível 2 e 1,13% no nível 3, tendo como referência o PF publicado na lista da CMED (arts. 2º e 3º). O ajuste é teto: a farmácia pode cobrar menos e conceder desconto. Alguns grupos, como homeopáticos, fitoterápicos e parte dos MIP, seguem critérios próprios da CMED; a lista publicada no portal da Anvisa mostra os preços de cada apresentação.

O QUE DIZ A NORMA

"As unidades de comércio varejista deverão manter à disposição dos consumidores e dos órgãos de proteção e defesa do consumidor as listas dos preços de medicamentos atualizadas, não podendo ser superiores aos preços publicados pela CMED no Portal da Anvisa." E a divulgação do PMC "deverá contemplar os diferentes preços decorrentes da incidência das cargas tributárias do [...] ICMS praticadas nos estados de destino" (Resolução CM-CMED nº 4/2026, art. 6º e parágrafo único).

Descumprir ato da CMED sujeita o infrator às sanções administrativas do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 10.742/2003, art. 8º). Cobrar acima do PMC é a infração mais comum no varejo, e acontece quando o sistema da loja não é atualizado depois do ajuste ou quando se usa a tabela de outro estado.

Código de Defesa do Consumidor no balcão

Regra	Base legal	Aplicação na farmácia
Informação adequada e clara sobre produto, preço e riscos	CDC, art. 6º, III; art. 31	Preço visível; orientação sobre uso e riscos faz parte do produto
Proteção contra publicidade enganosa e práticas abusivas	CDC, art. 6º, IV	Promessa de cura, "leve 3" de medicamento
Vedado condicionar a venda de um produto a outro (venda casada)	CDC, art. 39, I	Exigir compra de vitamina para vender o antibiótico

Regra	Base legal	Aplicação na farmácia
Vedado prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor por idade, saúde ou condição social	CDC, art. 39, IV	Empurrar produto caro a idoso confuso
Produto vencido ou alterado é impróprio ao consumo	CDC, art. 18, §6º, I e II	Troca imediata; vencido não pode estar à venda
Cadastro não solicitado deve ser comunicado por escrito; consumidor tem acesso aos seus dados	CDC, art. 43, caput e §2º	Cadastro de fidelidade e de desconto
Preço por etiqueta, código de barras ou relação de preços; havendo divergência, vale o menor	Lei 10.962/2004, arts. 2º, 3º e 5º	Gôndola com um preço e caixa com outro: cobra-se o menor
Desconto por forma de pagamento deve ser informado em local visível	Lei 10.962/2004, art. 5º-A	Preço diferente para PIX ou cartão
Exemplar do CDC em local visível e de fácil acesso	Lei 12.291/2010, art. 1º	Item conferido pelo Procon

O direito à informação do CDC e o dever de orientar da Lei 13.021/2014 (art. 13, VI) se somam. Orientação insuficiente sobre uso e riscos pode gerar responsabilidade civil da farmácia, além da ética do profissional.

ATENÇÃO

Desconto em medicamento não pode virar estímulo ao uso. A RDC 96/2008 proíbe usar medicamento como prêmio ou pontuação em programa de fidelidade (art. 10) e só permite comparação de preço ao consumidor entre intercambiáveis (art. 11).

NO BALCÃO

Cliente reclama que o preço do caixa está acima do da etiqueta. Cobre o menor (Lei 10.962/2004, art. 5º). Se reclamar de preço alto, mostre a lista de preços da CMED com o PMC do seu estado; ela precisa estar disponível na loja (Resolução CM-CMED 4/2026, art. 6º).

CASO

Fiscal do Procon pede a lista de preços de uma drogaria em abril. O sistema ainda usa a tabela de PMC do ano anterior, e dois produtos estão acima do PMC vigente porque a loja aplicou um ajuste maior que o autorizado para o nível 3. A drogaria responde pelas sanções do CDC (Lei 10.742/2003, art. 8º) e precisa corrigir o preço e atualizar a lista.

LGPD na farmácia

A **Lei Geral de Proteção de Dados** (LGPD, Lei 13.709/2018) vale para toda pessoa física ou jurídica que trata dados pessoais. A farmácia trata dados o dia inteiro: cadastro de cliente, CPF no caixa, receitas, registros de serviços farmacêuticos, escrituração de controlados, programas de desconto, entrega em domicílio. A autoridade fiscalizadora passou a se chamar Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) com a MP 1.317/2025, convertida na Lei 15.352/2026.

Conceitos aplicados

Conceito (art. 5º)	Na farmácia
Dado pessoal: informação de pessoa identificada ou identificável (I)	Nome, CPF, telefone, endereço, e-mail
Dado pessoal sensível: inclui dado referente à saúde (II)	Receita, medicamento comprado, resultado de glicemia, pressão aferida
Controlador: quem decide sobre o tratamento (VI)	A empresa dona da farmácia
Encarregado: canal entre controlador, titulares e ANPD (VIII)	Pessoa indicada pela empresa, com contato público (art. 41)
Tratamento: qualquer operação com dados (X)	Coletar, consultar, guardar, enviar ao laboratório, apagar

O histórico de compras de medicamentos revela informação de saúde. Por isso as regras de dado sensível se aplicam a qualquer tratamento que revele dados sensíveis e possa causar dano ao titular (art. 11, §1º). Saber que alguém compra antirretroviral, antidepressivo ou anticoncepcional é saber algo sobre a saúde dessa pessoa.

Bases legais mais usadas

Situação	Base legal possível	Artigo
Retenção e escrituração de receita de controlado e de antimicrobiano	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	Art. 11, II, a
Registro de serviço farmacêutico (aferição, acompanhamento)	Tutela da saúde por profissional ou serviço de saúde; a RDC 44/2009 exige consentimento expresso para esse registro (art. 64, §1º)	Art. 11, II, f
Cadastro em programa de desconto ou de fidelidade com histórico de compras	Consentimento específico e destacado, para finalidade específica	Art. 11, I
Envio de ofertas por mensagem	Consentimento; dados de saúde não podem ser usados para induzir consumo de medicamento	Art. 7º, I; RDC 44/2009, art. 59, parágrafo único

O QUE DIZ A NORMA

"É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde [...] em benefício dos interesses dos titulares de dados", para permitir a portabilidade pedida pelo titular ou as transações financeiras e administrativas desses serviços (LGPD, art. 11, §4º, redação da Lei 13.853/2019).

CPF no balcão e programas de desconto

Fora das situações em que a norma sanitária manda identificar o comprador (controlados, por exemplo), o CPF pedido no caixa serve a uma finalidade comercial: desconto, programa de fidelidade, programa de benefício do laboratório. Os princípios da finalidade, necessidade e transparência (art. 6º, I, III e VI) pedem que o cliente saiba para que o dado será usado, com quem será compartilhado e por quanto tempo será guardado (art. 9º). O consentimento precisa ser para finalidade determinada; autorização genérica é nula (art. 8º, §4º), e pode ser revogado a qualquer momento (art. 8º, §5º).

- Explique a finalidade antes de pedir o CPF e informe se o dado será compartilhado com laboratório ou administradora do programa.
- Não condicione a venda do medicamento ao cadastro; o desconto do programa é uma oferta, e o cliente pode recusar.
- Não fale em voz alta o nome do medicamento, o diagnóstico ou o CPF do cliente na fila.
- Atenda o pedido do titular: confirmação, acesso, correção, eliminação dos dados tratados com consentimento, informação sobre compartilhamento e revogação (art. 18).
- Confira se o seu estado ou município tem lei própria sobre a exigência de CPF no comércio.

Segurança, incidentes e sanções

A farmácia deve adotar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados contra acesso não autorizado, perda ou vazamento (art. 46) e comunicar à ANPD e ao titular incidente de segurança que possa causar risco ou dano relevante (art. 48). As sanções vão de advertência a multa simples de até 2% do faturamento no Brasil, limitada a R$ 50 milhões por infração, além de publicização da infração e bloqueio ou eliminação dos dados (art. 52). No plano profissional, o Código de Ética proíbe fornecer a terceiros dados que identifiquem paciente, prescritor ou estabelecimento em desacordo com a LGPD (Res. CFF 724/2022, art. 18, XLIII) e impõe o sigilo (art. 15, VI). A RDC 44/2009 manda tratar com sigilo os dados dos serviços farmacêuticos (art. 82).

NO BALCÃO

Login e senha do sistema e do certificado digital são pessoais. Emprestar a senha do SNGPC ou o certificado a um colega é proibido pelo Código de Ética (Res. CFF 724/2022, art. 18, XXIX) e deixa rastro de acesso no seu nome.

CASO

Um laboratório propõe à rede pagar por relatório mensal com CPF dos clientes e medicamentos de uso contínuo comprados, para "ações de adesão". O farmacêutico RT alerta que se trata de compartilhamento de dados de saúde para vantagem econômica, vedado fora das exceções da lei (LGPD, art. 11, §4º), e que fornecer dados identificáveis a terceiros é falta ética (Res. CFF 724/2022, art. 18, XLIII). A alternativa possível é relatório anonimizado ou programa em que o próprio paciente adere com consentimento específico.

Ética profissional e responsabilidade técnica

A ética do farmacêutico está no **Código de Ética da Profissão Farmacêutica**, aprovado pela Resolução CFF 724/2022, que também traz o Código de Processo Ético e as regras de sanção. Ela revogou a Resolução CFF 711/2021 e segue em vigor em outubro de 2026, citada como vigente em resoluções do CFF publicadas em 2026. A responsabilidade técnica é regulada pela Resolução CFF 721/2022, que revogou a Resolução CFF 577/2013.

Atividades privativas

O Decreto 85.878/1981 regulamenta a Lei 3.820/1960 e lista as atribuições privativas do farmacêutico. Para a farmácia comercial, as que importam são a dispensação ou manipulação de fórmulas quando a serviço do público (art. 1º, I) e o assessoramento e a responsabilidade técnica em depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza (art. 1º, II, d). O art. 2º lista atividades afins, não privativas, como análises clínicas e fabricação de cosméticos.

O QUE DIZ A NORMA

"São atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos: I - desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopéicas, quando a serviço do público em geral ou mesmo de natureza privada" (Decreto 85.878/1981, art. 1º, I).

Direção técnica, assistência e substituição

Função	O que é	Base
Diretor ou responsável técnico (RT)	Farmacêutico que realiza, supervisiona e coordena os serviços técnico-científicos no horário declarado e representa a empresa nos aspectos técnicos	Res. CFF 721/2022, arts. 2º, §1º, e 10, §1º
Farmacêutico assistente	Os "quantos outros forem necessários" para cobrir todo o horário, com função e horário anotados no CRF	Res. CFF 721/2022, arts. 3º e 9º
Farmacêutico substituto	Cobre impedimentos e ausências do RT, requerido ao CRF, com horário compatível	Lei 5.991/1973, art. 15, §2º; Res. CFF 721/2022, art. 2º, §2º

- A responsabilidade técnica é indelegável e exige participação efetiva e pessoal (Res. CFF 721/2022, art. 10). A RDC 44/2009 permite delegar algumas atribuições a outro farmacêutico, menos a supervisão e a responsabilidade pela assistência técnica (art. 20, parágrafo único).
- Cada farmacêutico responde pelos atos do horário que assumiu, com responsabilidade solidária quando comprovada (Res. CFF 721/2022, art. 10, §2º).
- Mudança de horário da loja ou do farmacêutico deve ser comunicada **previamente** ao CRF; sem isso, a certidão perde a validade (art. 11).
- O farmacêutico declara ao CRF que tem disponibilidade de horário; informação falsa gera sanção (art. 12).
- Ao sair da empresa, o profissional responde pelos atos do período em que deu assistência, por um ano após o fim do vínculo (Lei 5.991/1973, art. 16, §§1º e 2º), e comunica o CRF em até 5 dias úteis (Res. CFF 724/2022, art. 15, XII).
- A Lei 5.991/1973 limita a direção técnica a duas farmácias, uma comercial e uma hospitalar (art. 20).

Direitos, deveres e proibições mais cobrados

Tipo	Dispositivo (Res. CFF 724/2022)	Conteúdo resumido
Direito	Art. 12, IV	Negar-se a atos contrários à ciência, à ética e à técnica
Direito	Art. 12, IX	Fazer a intercambialidade respeitando a decisão do usuário e documentando
Direito	Art. 12, XIV	Decidir, justificadamente, sobre dispensar ou não qualquer prescrição
Dever	Art. 14, II e XII	Supervisionar colaboradores; supervisionar o conteúdo publicado pela loja em redes sociais e sites
Dever	Art. 14, IV e X	Avaliar a prescrição; orientar sobre benefícios, riscos, interações e uso
Dever	Art. 15, II	Recusar produto sem registro, sem rastreabilidade ou sem nota fiscal
Proibição	Art. 17, VIII	Delegar ou permitir que outros pratiquem atos privativos do farmacêutico
Proibição	Art. 17, XI e XVII	Intitular-se RT sem certidão do CRF; deixar de prestar assistência no horário declarado
Proibição	Art. 18, V	Permitir o uso do nome em estabelecimento onde não trabalha de fato
Proibição	Art. 18, XVII	Aceitar interferência de leigos nas decisões técnicas
Proibição	Art. 18, XXIV e XLI	Submeter-se a fins mercantilistas que comprometam a técnica; receber vantagem indevida

As sanções disciplinares, conforme a Lei 3.820/1960, são advertência (com ou sem a palavra "censura"), multa de 1 a 3 salários mínimos regionais, dobrada na reincidência, suspensão de 3 meses a 1 ano e

eliminação (Res. CFF 724/2022, art. 24). A competência para julgar é do CRF em que o profissional estava inscrito na época do fato, com recurso ao CFF (Lei 3.820/1960, art. 6º, e).

ATENÇÃO

Emprestar o nome para a loja abrir, sem trabalhar nela, é a falta conhecida como "farmacêutico de placa". Fere o Código de Ética (art. 18, V; art. 17, XVII) e deixa a loja sem farmacêutico, infração sanitária. O profissional responde nos dois planos.

NO BALCÃO

Quando for assumir uma loja, peça ao CRF a anotação de função e horário de cada farmacêutico, confira se a certidão afixada mostra os nomes e horários corretos e guarde cópia do contrato. Se a escala mudar, comunique antes (Res. CFF 721/2022, arts. 8º, 9º e 11).

CASO

A RT trabalha das 8h às 14h e o substituto das 14h às 22h. Num sábado, o substituto falta e o gerente mantém a loja aberta "só com o caixa". Um cliente compra um tarjado sem receita. A loja responde pela infração sanitária (Lei 6.437/1977, art. 10, XII) e por funcionar sem farmacêutico. O substituto que faltou ao horário declarado responde eticamente (Res. CFF 724/2022, art. 17, XVII); a RT não, pois não estava em seu horário, salvo se tivesse ciência e tolerasse a prática.

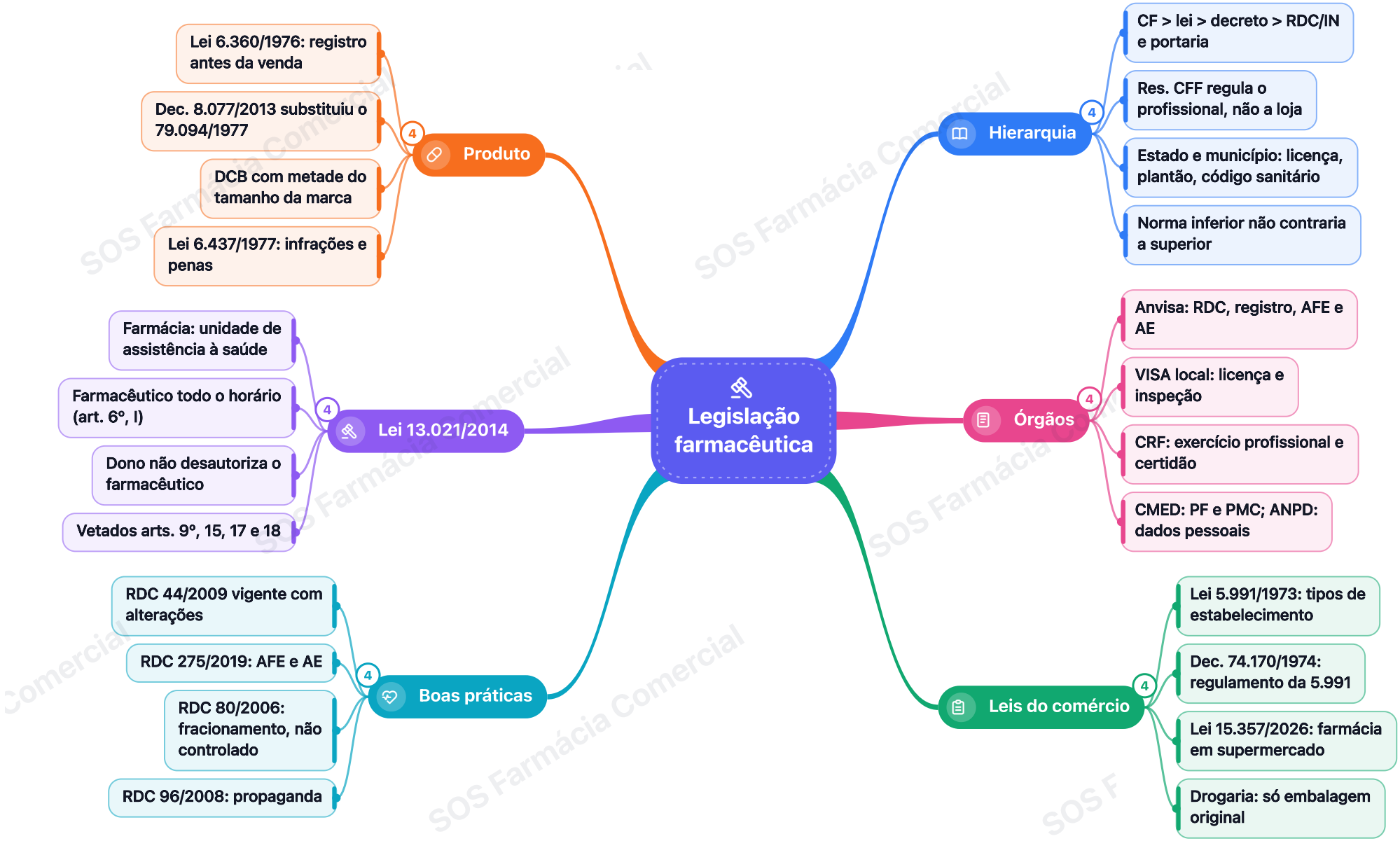
Fontes consultadas

1. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (arts. 5º, 22, 24, 30, 196 e 200), texto compilado. planalto.gov.br, consultado em 15/10/2026.
2. Brasil. Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960. Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia. Texto compilado, planalto.gov.br.
3. Brasil. Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, texto compilado com alterações até a Lei nº 15.357/2026. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5991.htm
4. Brasil. Decreto nº 74.170, de 10 de junho de 1974. Regulamenta a Lei nº 5.991/1973. Texto compilado, planalto.gov.br.
5. Brasil. Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, texto compilado. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm
6. Brasil. Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013. Regulamenta a Lei nº 6.360/1976 e revoga o Decreto nº 79.094/1977. planalto.gov.br.
7. Brasil. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, texto compilado. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6437.htm
8. Brasil. Decreto nº 85.878, de 7 de abril de 1981. Normas para execução da Lei nº 3.820/1960. planalto.gov.br.
9. Brasil. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), texto compilado. planalto.gov.br.
10. Brasil. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Define o SNVS e cria a Anvisa. Texto compilado, planalto.gov.br.
11. Brasil. Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 (medicamento genérico). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9787.htm
12. Brasil. Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003 (regulação do setor farmacêutico e CMED). planalto.gov.br.
13. Brasil. Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004 (oferta e afixação de preços), texto compilado. planalto.gov.br.

14. Brasil. Lei nº 12.291, de 20 de julho de 2010 (exemplar do CDC nos estabelecimentos). planalto.gov.br.
15. Brasil. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, e Mensagem de veto nº 232, de 8 de agosto de 2014. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13021.htm
16. Brasil. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), texto compilado com alterações até a Lei nº 15.352/2026. planalto.gov.br.
17. Brasil. Lei nº 15.352, de 25 de fevereiro de 2026 (Agência Nacional de Proteção de Dados). planalto.gov.br.
18. Brasil. Lei nº 15.357, de 20 de março de 2026. Altera a Lei nº 5.991/1973 (farmácia ou drogaria na área de venda de supermercados). DOU de 23/03/2026. planalto.gov.br.
19. Anvisa. RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009 (Boas Práticas Farmacêuticas), texto consolidado no AnvisaLegis (vigente com alterações), consultado em 15/10/2026.
20. Anvisa. RDC nº 275, de 9 de abril de 2019 (AFE e AE de farmácias e drogarias), texto consolidado no AnvisaLegis, consultado em 15/10/2026.
21. Anvisa. RDC nº 17, de 28 de março de 2013, revogada pela RDC nº 275/2019 (AnvisaLegis).
22. Anvisa. RDC nº 16, de 2 de março de 2007 (Regulamento técnico de genéricos), texto consolidado no AnvisaLegis, Anexo I, item VI.
23. Anvisa. RDC nº 58, de 10 de outubro de 2014 (intercambialidade de similares), texto consolidado no AnvisaLegis.
24. Anvisa. Medicamentos similares: intercambialidade. Portal gov.br/anvisa, consultado em 15/10/2026.
25. Anvisa. RDC nº 80, de 11 de maio de 2006 (fracionamento de medicamentos). Texto original na BVS/MS.
26. Anvisa. RDC nº 96, de 17 de dezembro de 2008 (propaganda de medicamentos), texto consolidado no AnvisaLegis.
27. Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Resolução CM-CMED nº 4, de 30 de março de 2026. DOU de 31/03/2026, Seção 1, p. 33. gov.br/anvisa.
28. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 721, de 24 de fevereiro de 2022 (direção ou responsabilidade técnica). DOU, 2022. in.gov.br
29. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 724, de 29 de abril de 2022 (Código de Ética, Código de Processo Ético e sanções). DOU, 2022. in.gov.br
30. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 6, de 25 de junho de 2026 (cuidado paliativo), cujos considerandos citam a Resolução CFF nº 724/2022 como norma em vigor. DOU, 03/07/2026.

Quem regula a farmácia

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 1



Legislação no balcão

6 ramos · 25 itens · mapa mental do módulo 1

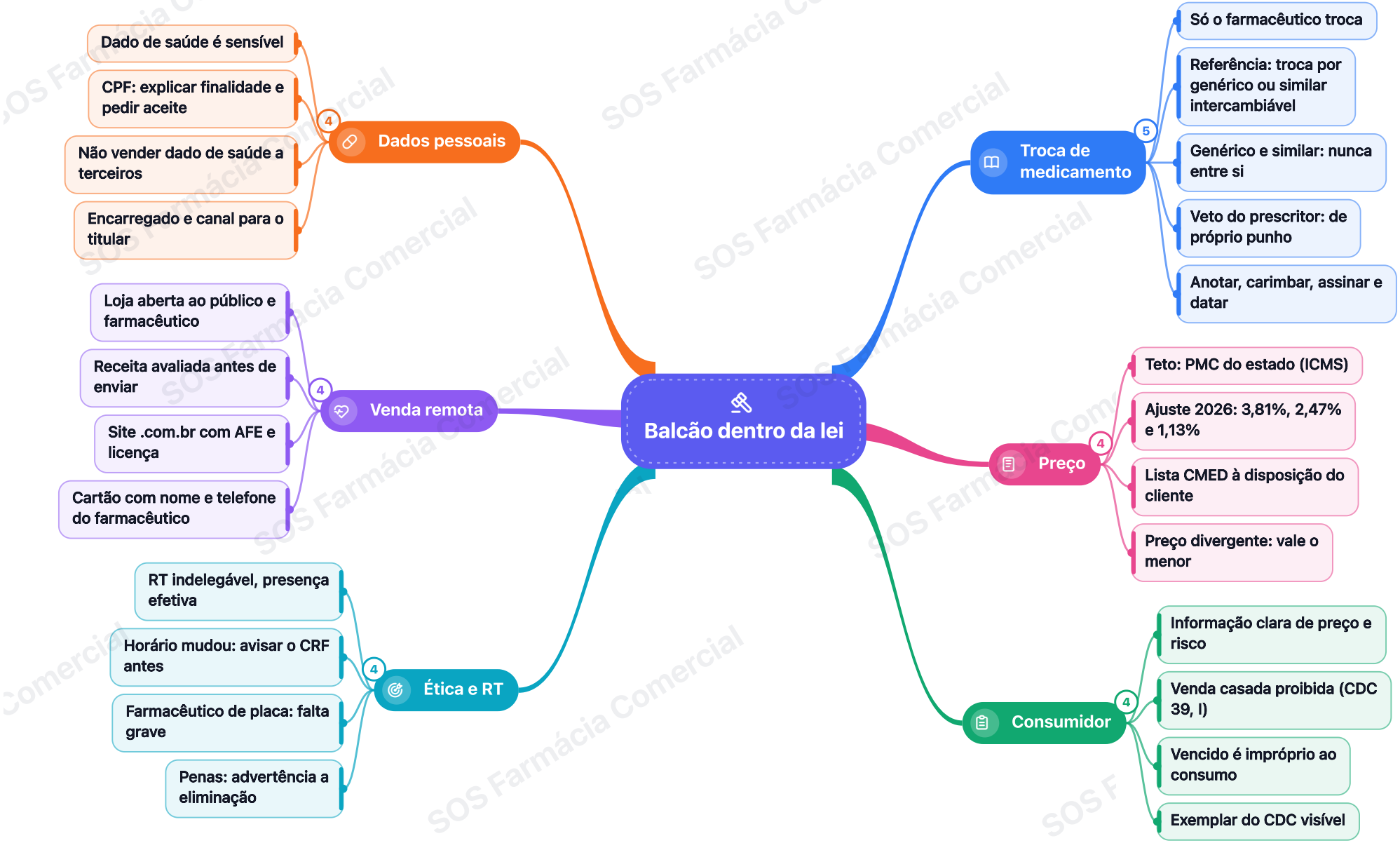


Tabela-mestra: norma, assunto e o que o farmacêutico precisa saber

Norma	Assunto	O que o farmacêutico precisa saber
Constituição Federal, arts. 196, 200 e 24, XII	Saúde e vigilância sanitária	Vigilância sanitária é ação do SUS; União, estados e municípios legislam sobre saúde
Lei 3.820/1960	Cria CFF e CRFs	Só inscrito no CRF exerce a profissão (art. 13); empresa prova ter farmacêutico (art. 24)
Lei 5.991/1973	Comércio de medicamentos	Farmácia, drogaria, posto, dispensário; licença local; receituário (art. 35)
Decreto 74.170/1974	Regulamenta a Lei 5.991	Correlatos permitidos (art. 4º); fracionamento (art. 9º, parágrafo único)
Lei 6.360/1976	Vigilância sanitária de produtos	Registro antes da venda (art. 12); definições de genérico e similar (art. 3º)
Decreto 8.077/2013	Regulamenta a Lei 6.360	Autorização da Anvisa e licença local para funcionar (art. 2º)
Lei 6.437/1977	Infrações e penalidades sanitárias	Vender tarjado sem receita (art. 10, XII); aviar receita em desacordo (XI)
Decreto 85.878/1981	Atribuições do farmacêutico	Dispensação é privativa do farmacêutico (art. 1º, I)
Lei 8.078/1990 (CDC)	Defesa do consumidor	Informação clara, sem venda casada, vencido é impróprio
Lei 9.782/1999	SNVS e Anvisa	Anvisa autoriza o funcionamento de quem comercializa medicamentos (art. 7º, VII)
Lei 9.787/1999	Genéricos	Prescrição pela DCB no SUS (art. 3º); respeitar veto de não intercambialidade
RDC 16/2007, Anexo I, item VI	Prescrição e dispensação de genéricos	Farmacêutico troca e registra na receita; veto de próprio punho
RDC 58/2014	Similar intercambiável	Lista no portal da Anvisa; frase na bula; não vale para MIP
Lei 10.742/2003	CMED e preços	Teto de preço; descumprimento sujeita às sanções do CDC (art. 8º)
Resolução CM-CMED 4/2026	Ajuste anual de 2026	Lista de preços atualizada à disposição do consumidor (art. 6º)

Norma	Assunto	O que o farmacêutico precisa saber
Lei 10.962/2004	Afixação de preços	Divergência de preço: o consumidor paga o menor (art. 5º)
RDC 80/2006	Fracionamento	Só de embalagem fracionável; nunca controlado; responsabilidade do farmacêutico
RDC 96/2008	Propaganda de medicamentos	Medicamento não é prêmio de fidelidade (art. 10)
RDC 44/2009	Boas práticas em farmácias e drogarias	Documentos (art. 2º), dispensação (arts. 43 a 51), venda remota (arts. 52 a 59)
Lei 13.021/2014	Exercício das atividades farmacêuticas	Farmacêutico todo o horário; dono não desautoriza; deveres do art. 13
LGPD, Lei 13.709/2018	Proteção de dados	Dado de saúde é sensível (art. 5º, II); vedado compartilhar para vantagem econômica (art. 11, §4º)
RDC 275/2019	AFE e AE de farmácias e drogarias	AFE não autoriza atividade fora da licença (art. 4º, §4º)
Res. CFF 721/2022	Responsabilidade técnica	Certidão com todos os farmacêuticos e horários; avisar mudança antes
Res. CFF 724/2022	Código de Ética	Direito de recusar dispensação justificadamente; proibição de delegar ato privativo
Lei 15.357/2026	Farmácia em supermercado e entrega	Espaço exclusivo; controlado só após pagamento ou lacrado; plataformas para entrega

Normas de controlados (Portaria 344/98, RDC 1.000/2025), antimicrobianos (RDC 471/2021) e MIP (RDC 882/2024, IN 285/2024) têm módulos próprios.

Quem fiscaliza o quê

Fiscal	O que verifica	Base	Consequência típica
Vigilância sanitária (VISA)	Licença, AFE, armazenamento, receitas, escrituração, serviços, validade	Lei 5.991/1973, art. 44; RDC 44/2009	Termo de inspeção, auto de infração, interdição (Lei 6.437/1977)
CRF	Farmacêutico presente, certidão, horários, conduta ética	Lei 3.820/1960, art. 10; Lei 13.021/2014	Auto do CRF, processo ético, multa ao estabelecimento
Procon	Preço acima do PMC, informação, venda casada, exemplar do CDC	CDC; Lei 10.742/2003, art. 8º	Sanções do art. 56 do CDC
ANPD	Tratamento de dados pessoais e incidentes	LGPD, arts. 52 e seguintes	Advertência, multa, bloqueio de dados

Linha do tempo da legislação farmacêutica

Ano	Norma	O que mudou
1960	Lei 3.820	Cria o CFF e os CRFs
1973	Lei 5.991	Define farmácia, drogaria e regras do comércio de medicamentos
1974	Decreto 74.170	Regulamenta a Lei 5.991
1976	Lei 6.360	Registro e rotulagem de produtos sujeitos à vigilância sanitária
1977	Lei 6.437	Infrações sanitárias e penalidades
1981	Decreto 85.878	Atribuições privativas do farmacêutico
1988	Constituição Federal	Saúde como direito; vigilância sanitária no SUS
1990	Lei 8.078 (CDC)	Direitos do consumidor
1998	Portaria SVS/MS 344	Medicamentos sujeitos a controle especial
1999	Lei 9.782 e Lei 9.787	Cria a Anvisa e o medicamento genérico
2003	Lei 10.742	Cria a CMED e a regulação de preços
2006	RDC 80	Fracionamento em farmácias e drogarias
2007	RDC 16	Regulamento de genéricos (critérios de dispensação ainda vigentes)
2008	RDC 96	Propaganda de medicamentos
2009	RDC 44	Boas práticas farmacêuticas em farmácias e drogarias
2012	RDC 41	MIP em autosserviço
2013	Decreto 8.077	Novo regulamento da Lei 6.360
2014	Lei 13.021 e RDC 58	Farmácia como unidade de saúde; similar intercambiável
2018	Lei 13.709 (LGPD)	Proteção de dados pessoais
2019	RDC 275	AFE e AE de farmácias e drogarias
2022	Res. CFF 721 e 724	Responsabilidade técnica e Código de Ética vigentes
2023	RDC 812	Entrega remota de controlados
2024	RDC 882	Novos critérios de enquadramento de MIP
2025	RDC 978 e RDC 1.000	Exames em farmácia; receituários de controlados

Ano	Norma	O que mudou
2026	Lei 15.352, Lei 15.357 e Res. CM-CMED 4	ANPD vira agência; farmácia em supermercado; ajuste de preços de 2026

Documentos que a farmácia precisa ter em dia

- ◯ AFE publicada no DOU, com as atividades que a loja realmente exerce (RDC 275/2019)
- ◯ AE, se a farmácia manipula substâncias da Portaria 344/98
- ◯ Licença sanitária vigente, afixada, com todos os serviços prestados listados (RDC 44/2009, arts. 2º e 61)
- ◯ Certidão de Regularidade do CRF afixada, com nome e horário de todos os farmacêuticos e do substituto (Res. CFF 721/2022, art. 8º)
- ◯ Cartaz com razão social, CNPJ, AFE, RT, horários e telefones do CRF e da VISA, se faltarem nos documentos afixados (RDC 44/2009, art. 2º, §2º)
- ◯ Manual de Boas Práticas e POPs assinados pelo RT (RDC 44/2009, arts. 85 e 86)
- ◯ Lista atualizada de genéricos visível ao usuário (RDC 44/2009, art. 42, §1º)
- ◯ Lista de serviços públicos de saúde próximos, com endereço e telefone (RDC 44/2009, art. 62)
- ◯ Cartaz "Medicamentos podem causar efeitos indesejados" na área de medicamentos (RDC 44/2009, art. 41)
- ◯ Lista de preços da CMED atualizada, com o PMC do estado (Resolução CM-CMED 4/2026, art. 6º)
- ◯ Exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local visível (Lei 12.291/2010)
- ◯ Contratos e anotação de função e horário de cada farmacêutico no CRF (Res. CFF 721/2022, art. 9º)
- ◯ Escrituração de controlados e antimicrobianos em dia e receitas retidas arquivadas
- ◯ Site com os dados obrigatórios e endereço informado na AFE, se vende pela internet (RDC 44/2009, arts. 53 e 55)
- ◯ Aviso de privacidade e contato do encarregado de dados publicados (LGPD, arts. 9º e 41)

Posso substituir este medicamento?

Cliente pede para trocar o medicamento da receita

DECISÃO

Quem vai decidir é farmacêutico?

- **SIM** — Seguir
- **NÃO** — Chamar o farmacêutico; balconista não decide troca

DECISÃO

O prescritor vetou a troca de próprio punho naquele item?

- **SIM** — Não trocar; dispensar o prescrito ou contatar o prescritor
- **NÃO** — Seguir

DECISÃO

Mesmo princípio ativo, concentração, forma farmacêutica e via?

- **SIM** — Seguir
- **NÃO** — Não trocar; só o prescritor muda substância, dose ou forma

DECISÃO

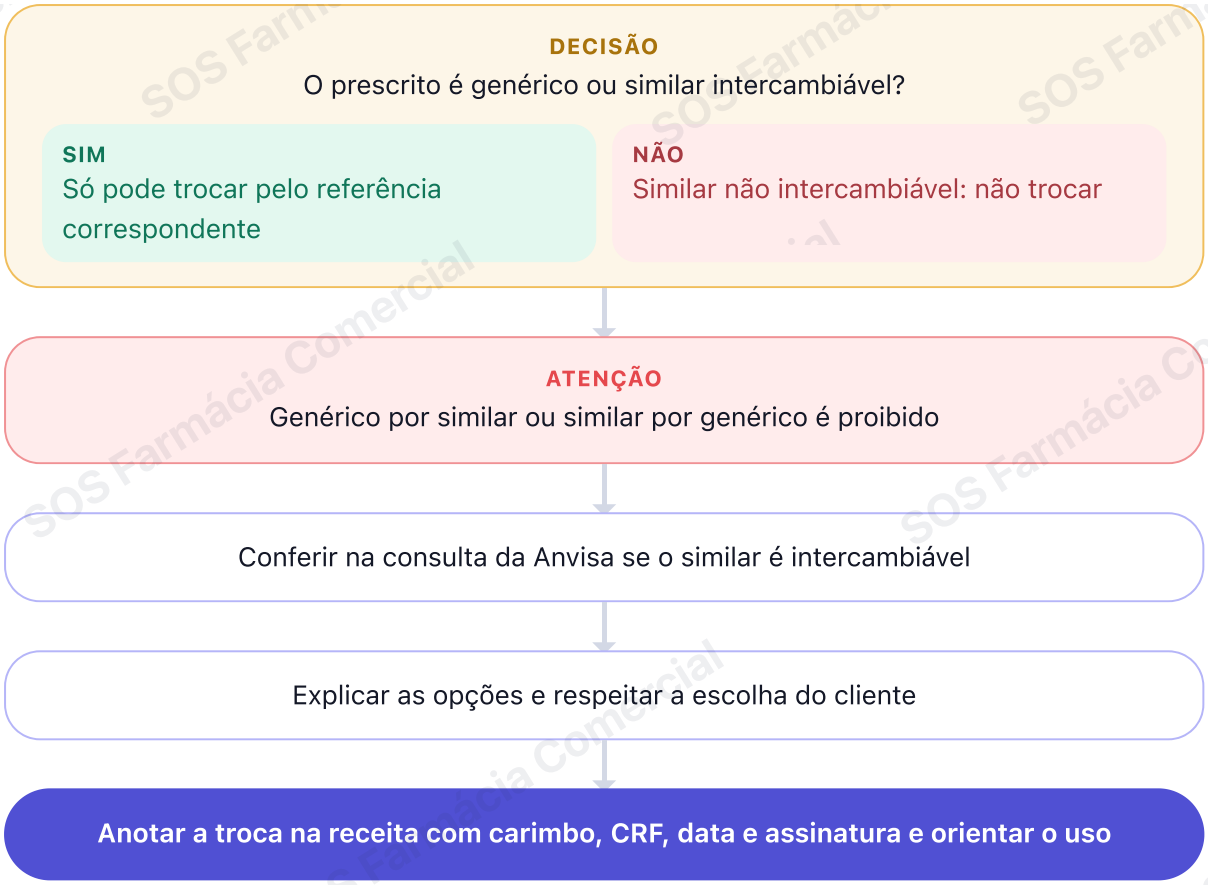
A receita está escrita pela DCB?

- **SIM** — Dispensar o genérico ou o referência correspondente
- **NÃO** — Seguir

DECISÃO

O prescrito é o referência?

- **SIM** — Pode trocar pelo genérico ou por similar intercambiável com esse referência
- **NÃO** — Seguir



Cartões de revisão

Pergunta	Resposta
Qual lei define farmácia e drogaria?	Lei 5.991/1973, art. 4º, X e XI; a Lei 13.021/2014 fala em farmácia com e sem manipulação.
Drogaria pode manipular ou captar receita magistral?	Não. Captar receita magistral é vedado mesmo entre filiais (Lei 5.991/1973, art. 36, §1º; RDC 44/2009, art. 50).
O que a Lei 15.357/2026 permitiu?	Farmácia em área de supermercado, em espaço exclusivo, com farmacêutico todo o horário, e uso de plataformas para entrega.
Qual decreto regulamenta hoje a Lei 6.360/1976?	Decreto 8.077/2013, que revogou o Decreto 79.094/1977.
Qual artigo da Lei 13.021/2014 exige farmacêutico durante todo o horário?	Art. 6º, I.
Quais artigos da Lei 13.021/2014 foram vetados?	Arts. 9º, 15, 17 e 18 (Mensagem de veto 232/2014).
Prazo para contratar novo farmacêutico após a baixa?	30 dias (Lei 13.021/2014, art. 12).
Genérico pode ser trocado por similar intercambiável?	Não. Ambos foram comparados ao referência, não entre si.

Pergunta	Resposta
Como o prescritor veta a troca?	Por item, de forma clara e legível, de próprio punho (RDC 16/2007, Anexo I, VI, 1.3).
Quem pode fazer a substituição na farmácia?	O farmacêutico, que anota na receita com carimbo, CRF, data e assinatura.
Qual norma trata da AFE de farmácias e drogarias?	RDC 275/2019. A AE só é exigida de farmácia que manipula substâncias da Portaria 344/98.
Controlado pode ser fracionado?	Não (RDC 80/2006, art. 1º, parágrafo único).
Que domínio o site da farmácia deve usar?	".com.br" (RDC 44/2009, art. 53, §1º).
Teto de ajuste de preços em 2026?	3,81%, 2,47% e 1,13% conforme o nível (Resolução CM-CMED 4/2026, art. 3º).
Preço da gôndola diferente do caixa: qual vale?	O menor (Lei 10.962/2004, art. 5º).
Dado de compra de medicamento é sensível?	Sim, revela dado de saúde (LGPD, art. 5º, II, e art. 11, §1º).
Qual resolução do CFF trata da responsabilidade técnica?	Res. CFF 721/2022, que revogou a 577/2013.
Sanções éticas da Res. CFF 724/2022?	Advertência, multa de 1 a 3 salários mínimos regionais, suspensão de 3 meses a 1 ano e eliminação (art. 24).

Questões de fixação

1. Uma drogaria quer ampliar o negócio. Entre as atividades abaixo, qual ela pode exercer sem mudar de natureza, desde que conste da licença sanitária?

A Manipular cremes a partir de receitas de dermatologistas.

B Receber receitas magistrais e repassá-las a uma farmácia de manipulação da mesma rede.

C Dispensar medicamentos fracionados a partir de embalagem fracionável.

D Dispensar plantas medicinais a granel.

E Manipular substâncias da Portaria 344/98 com AE.

2. Receita particular traz o nome comercial de um similar intercambiável de anlodipino 5 mg, sem veto de troca. O cliente pede o genérico, que é mais barato. O farmacêutico deve:

A dispensar o genérico, pois genéricos e similares são intercambiáveis entre si.

B dispensar o genérico, desde que anote a troca no verso da receita.

C recusar a dispensação, pois toda receita com nome comercial de similar exige contato prévio com o prescritor.

D dispensar o genérico se o cliente assinar declaração de ciência.

E explicar que a troca só é possível pelo referência e oferecer o similar prescrito ou o referência.

3. Sobre a Lei 13.021/2014, assinale a alternativa correta.

A Revogou integralmente a Lei 5.991/1973.

B Atribuiu ao fiscal farmacêutico do CRF a fiscalização sanitária das farmácias.

C Determinou que postos de medicamentos se transformassem em farmácia em 3 anos.

D Proíbe que o proprietário desautorize as orientações técnicas do farmacêutico.

E Restringiu às farmácias a venda de cosméticos com indicação terapêutica e de fitoterápicos.

4. Farmacêutico assume a RT de uma drogaria que abre das 7h às 23h. Ele trabalhará das 7h às 15h. Segundo a Res. CFF 721/2022 e a Lei 13.021/2014, é necessário:

A que outro farmacêutico, com função e horário anotados no CRF, cubra o restante do horário.

B que o gerente assine termo de responsabilidade para o período sem farmacêutico.

C apenas que o RT deixe os POPs assinados para os balconistas seguirem.

D que a loja não venda controlados após as 15h, liberando os demais.

E nada, pois a responsabilidade técnica do RT abrange todo o horário de funcionamento, mesmo na sua ausência.

5. Na fiscalização do Procon, constata-se que uma drogaria do Ceará cobra por um anti-hipertensivo valor acima do PMC publicado para o estado. Assinale a afirmativa correta.

A O PMC é sugestão do fabricante e não obriga a farmácia.

B A farmácia pode cobrar acima do PMC se oferecer desconto no cartão fidelidade.

C O PMC é único no país, sem variação de ICMS.

D A farmácia descumpre ato da CMED e fica sujeita às sanções do art. 56 do CDC.

E Só a Anvisa pode autuar, pois preço é assunto sanitário.

6. Uma rede quer vender medicamentos por site e aplicativo. Qual exigência decorre da RDC 44/2009?

A O estoque pode ficar em um centro de distribuição fechado ao público, sem farmácia.

B O site pode exibir banners de anti-hipertensivos em promoção.

C Tarjados exigem que o farmacêutico receba e avalie a receita.

D O site pode usar domínio ".com" se a empresa tiver CNPJ.

E Controlados podem ser vendidos livremente após o pagamento on-line.

7. Cliente de 52 anos recusa informar CPF no caixa. A atendente diz que sem CPF "o sistema não deixa vender" a dipirona. Com base na LGPD e no CDC, a melhor conduta do farmacêutico é:

A confirmar a exigência, pois todo medicamento, inclusive isento de prescrição, exige identificação do comprador.

B vender sem CPF, explicando que o cadastro serve ao programa de desconto e é opcional.

C pedir RG no lugar do CPF, para cumprir a escrituração sanitária.

D registrar a venda no CPF de outro cliente cadastrado.

E vender e registrar o CPF depois, a partir de consulta pública.

8. Paciente apresenta receita de omeprazol 20 mg pelo nome do referência. Ao lado do item, há carimbo impresso com a frase "não autorizo a substituição". O farmacêutico deve considerar que:

A o veto é válido, pois está escrito de forma legível.

B o carimbo vale como veto para todos os itens da receita, inclusive os genéricos.

C o veto não vale, porque deve ser escrito de próprio punho.

D a troca está proibida para qualquer medicamento de referência.

E basta o paciente concordar para afastar qualquer veto do prescritor.

9. Durante inspeção, o fiscal da VISA verifica que a drogaria tem AFE com a atividade "prestação de serviços farmacêuticos", mas a licença sanitária não lista esse serviço. A drogaria aplica injetáveis. Assinale a correta.

A A AFE basta, pois é ato da Anvisa, de âmbito federal, e prevalece sobre a licença sanitária local.

B O serviço é irregular, pois só são regulares os serviços indicados no licenciamento.

C O serviço é regular se houver POP assinado pelo RT.

D Basta comunicar o CRF para regularizar.

E A aplicação de injetáveis independe de licença por ser ato do farmacêutico.

10. Uma farmacêutica aceita constar como RT de uma drogaria em outra cidade, onde nunca vai, em troca de pagamento mensal. Essa conduta:

A é permitida se ela visitar a loja ao menos uma vez por mês e assinar os POPs.

B é infração apenas da empresa, e não da profissional contratada.

C é regular se houver contrato de trabalho registrado.

D só é proibida se a drogaria vender controlados.

E é falta ética, pois ela permite o uso do nome onde não exerce a função.

11. Um laboratório oferece pagamento a uma rede de farmácias em troca da lista de clientes que compram seu antidiabético, com CPF e frequência de compra, para enviar publicidade. À luz da LGPD, essa operação:

A é permitida, pois o CPF é um dado público e de livre circulação.

B é permitida se a farmácia tiver encarregado nomeado.

C é vedada, pois compartilha dado de saúde para vantagem econômica.

D é permitida se os dados forem enviados criptografados ao laboratório.

E é vedada apenas se os clientes forem menores de idade.

Gabarito comentado

1. **C**. Correta C: farmácias e drogarias podem fracionar a partir de embalagem fracionável (RDC 80/2006, art. 1º; Decreto 74.170/1974, art. 9º, parágrafo único). A e E: manipulação é própria da farmácia (Lei 5.991/1973, art. 4º, X e XI). B: captação de receita magistral é vedada, mesmo entre filiais (art. 36, §1º; RDC 44/2009, art. 50). D: plantas medicinais são privativas de farmácias e ervanarias (art. 7º).
2. **E**. Correta E: o similar intercambiável é equivalente ao referência, e a Anvisa informa que a troca entre similar e genérico não é possível, porque os dois não foram comparados entre si (RDC 58/2014, art. 2º). A, B e D permitem troca não admitida; anotar ou colher assinatura não a torna regular. C: a receita é válida e pode ser dispensada como está.
3. **D**. Correta D (art. 11). A: a Lei 5.991/1973 segue vigente. B, C e E correspondem aos arts. 15, 17 e 9º, vetados pela Mensagem 232/2014; a fiscalização sanitária continua com a VISA.
4. **A**. Correta A: farmácia de qualquer natureza deve ter quantos farmacêuticos forem necessários para cobrir todo o horário, com horários anotados no CRF (Res. CFF 721/2022, arts. 3º e 9º; Lei 13.021/2014, art. 6º, I). B e C delegam a leigos ato do farmacêutico (Res. CFF 724/2022, art. 17, VIII). D aplica fora de contexto o art. 17 da Lei 5.991/1973. E confunde responsabilidade com presença; a RT exige participação efetiva (Res. CFF 721/2022, art. 10).
5. **D**. Correta D: o varejo não pode praticar preço superior ao publicado pela CMED (Resolução CM-CMED 4/2026, art. 6º), e o descumprimento sujeita às sanções do CDC (Lei 10.742/2003, art. 8º). A e B: o PMC é teto obrigatório. C: o PMC varia conforme o ICMS do estado (art. 6º, parágrafo único). E: Procon é órgão de defesa do consumidor e pode fiscalizar.
6. **C**. Correta C (art. 52, §1º). A: o estoque deve estar em farmácia ou drogaria aberta ao público (art. 52, §3º). B: é vedada propaganda de tarjado no site (art. 54). D: o domínio deve ser ".com.br" (art. 53, §1º). E: controlados pedidos a distância são vedados, salvo as exceções da legislação específica (art. 52, §2º, redação da RDC 812/2023).
7. **B**. Correta B: fora das hipóteses sanitárias de identificação, o CPF tem finalidade comercial; o tratamento exige finalidade informada e consentimento específico (LGPD, arts. 6º, 8º, §4º, e 11, I), e a venda não deve ser condicionada ao cadastro. A e C: MIP não exige identificação do comprador. D e E violam a LGPD e falseiam registros.
8. **C**. Correta C: a não intercambialidade deve ser manifestada por item, de forma clara, legível e inequívoca, de próprio punho, não sendo permitidas outras formas de impressão (RDC 16/2007, Anexo I, VI, 1.3). A e B ignoram a forma exigida. D: não existe proibição geral. E: veto válido do prescritor prevalece sobre a vontade do paciente (Lei 9.787/1999, art. 2º, IV).
9. **B**. Correta B: RDC 44/2009, art. 61, §§3º e 4º; a AFE não autoriza atividade que não esteja na licença (RDC 275/2019, art. 4º, §§4º e 5º). A, C, D e E: POP, AFE e comunicação ao CRF não substituem a licença sanitária com o serviço incluído após inspeção prévia.
10. **E**. Correta E: Res. CFF 724/2022, art. 18, V, e art. 17, XVII; a RT é indelegável e exige participação efetiva e pessoal (Res. CFF 721/2022, art. 10). A, C e D: contrato ou visita eventual não suprem a presença (Lei 13.021/2014, art. 6º, I). B: a profissional responde eticamente e a empresa, sanitariamente.
11. **C**. Correta C: LGPD, art. 11, §4º; o uso de dados para induzir consumo de medicamento também é vedado pela RDC 44/2009 (art. 59, parágrafo único), e fornecer dado identificável a terceiros é falta ética (Res. CFF 724/2022, art. 18, XLIII). A: dado de compra de medicamento é sensível. B e D: encarregado e criptografia não criam base legal. E: a vedação não depende da idade.